ความก้าวหน้า ไม่ได้เกิดขึ้นเอง

หมอเพิ่มขึ้นแล้ว ทำไมบางจังหวัดยังขาด?

ประเทศไทยมีแพทย์มากขึ้น แต่คนในแต่ละจังหวัดยังเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ไม่เท่ากัน ปัญหาจึงไม่ใช่แค่ “มีหมอกี่คน” แต่คือ “หมออยู่ที่ไหน และมีเพียงพอกับงานหรือไม่” ต่อให้ผลิตแพทย์เพิ่ม หากพื้นที่ที่ขาดไม่มีตำแหน่งและงบจ้างรองรับ ก็ส่งแพทย์ไปไม่ได้

> **“ตำแหน่งที่รัฐกำหนดคือรูปธรรมของการระบุความรับผิดชอบของรัฐกับพันธะต่อประชาชนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า”**
>
> จากรายงานผลการวิจัย

8 จังหวัดสีชมพู ได้แก่ บึงกาฬ, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, กำแพงเพชร, อำนาจเจริญ, ยโสธร, เลย, สกลนคร อยู่ในกลุ่ม 19 จังหวัดที่มีแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้อยที่สุดในทุกเกณฑ์ทั้งสี่แบบ ได้แก่ ประชากร ปริมาณบริการ การใช้บริการที่ปรับให้เปรียบเทียบกันได้ และภาระความเจ็บป่วย

45,937
แพทย์ทั้งรัฐและเอกชนใน พ.ศ. 2568
เพิ่มจาก 26,767 คนใน พ.ศ. 2556

8
จังหวัดที่แพทย์น้อยทุกเกณฑ์
แพทย์เทียบกับประชากรและงานตามแผนที่ด้านบน

43.7%
ของเป้าแพทย์ที่ 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดจะมีใน พ.ศ. 2583 ถ้าเพิ่มตำแหน่งให้ที่ขาดก่อน
เป้าตัวอย่างคือแพทย์ต่อประชากร 1:1,000 ถ้าเพิ่มตามสัดส่วนเดิมจะได้ร้อยละ 39.0

16%
คิดออกจากราชการหรือสังกัดในสามปี
ผลสำรวจถ่วงน้ำหนัก ผู้ตอบ 734 คนใน 66 จังหวัด

งานวิจัยนี้หาคำตอบอย่างไร?

ทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาจำนวนบุคลากรงานรักษาพยาบาล ความเจ็บป่วยของประชาชน ตำแหน่งที่จ้างได้ และเหตุผลที่ทำให้คนอยากอยู่หรืออยากออกจากงาน พร้อมทดลองจัดสรรแพทย์กระทรวงสาธารณสุขใน 76 จังหวัดด้วยแบบจำลอง เพื่อดูว่าวิธีไหนช่วยพื้นที่ขาดแคลนได้มากกว่า

ในฉบับนี้

1 ห้าข้อค้นพบ หมอเพิ่มแล้ว เหตุใดยังขาด
2 เจ็ดเรื่องที่ต้องทำพร้อมกัน
3 สี่คำถามที่สังคมต้องร่วมตัดสิน
4 แบบจำลองช่วยตัดสินใจได้ แต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

psitthirat.github.io/HRH-model

ห้าข้อค้นพบ

หมอเพิ่มแล้ว เหตุใดยังขาด

การศึกษาครั้งนี้ดูจำนวนบุคลากร งานที่รับผิดชอบ ตำแหน่งที่จ้างได้ และชีวิตคนทำงาน

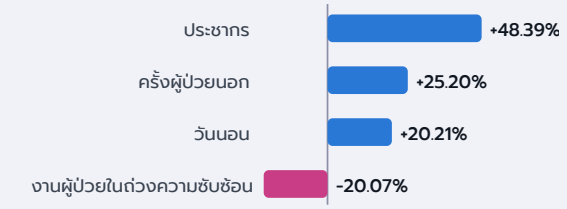
ข้อค้นพบที่ 1

นับจำนวนหมออย่างเดียว อาจตอบผิดคำถาม

เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร แพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.39 ระหว่างปี 2556–2568 แต่ถ้าเทียบกับงานผู้ป่วยในที่ให้น้ำหนักตามความซับซ้อน ในปีงบประมาณ 2561–2568 กลับลดลงร้อยละ 20.07 ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนระบบจัดกลุ่มโรค มีหมอเพิ่มจึงไม่ได้แปลว่ามีคนพอรับภาระงานที่หนักขึ้น

-20.07% แพทย์กระทรวงสาธารณสุขต่องานผู้ป่วยในที่ให้น้ำหนักตามความซับซ้อน ปีงบประมาณ 2561–2568

แพทย์กระทรวงสาธารณสุขเทียบกับคนและงาน เปลี่ยนไปร้อยละเท่าใด



ร้อยละที่เปลี่ยนของแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อแต่ละสิ่งที่นำมาเทียบ พ.ศ. 2556–2568 ยกเว้นงานผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561–2568

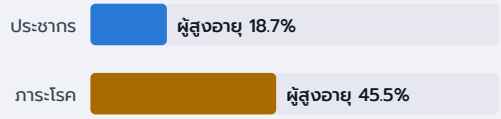
ข้อค้นพบที่ 2

พื้นที่ที่คนเจ็บป่วยมาก มักมีหมอน้อย

คนอายุหกสิบปีขึ้นไปมีร้อยละ 18.7 ของประชากร แต่มีภาระโรคร้อยละ 45.5 ภาระโรคคือสุขภาพดีที่เสียไปจากการเจ็บป่วยและตายก่อนวัย แพทย์ทั้งรัฐและเอกชนกลับอยู่มากในจังหวัดที่ภาระโรคต่ำ จึงควรจัดแพทย์ตามความเจ็บป่วย ไม่ใช่แค่จำนวนคนที่มาโรงพยาบาล ซึ่งไม่นับคนที่เข้าไม่ถึงบริการ

45.5% ของภาระโรคอยู่กับผู้สูงอายุ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 18.7 ของประชากร

ผู้สูงอายุ: สัดส่วนประชากรเทียบสัดส่วนภาระโรค



ผู้สูงอายุคืออายุหกสิบปีขึ้นไป ภาระโรคจากการศึกษาภาระโรค ค.ศ. 2022

ข้อค้นพบที่ 3

รับคนใหม่ แต่ยังต้องชดเชยคนที่ออก

พยาบาลวิชาชีพที่รับใหม่ราว 8 ใน 10 คนเป็นการทดแทนคนที่ออก แม้บรรจุแพทย์ครบตามตำแหน่ง จังหวัดที่มีแพทย์กระทรวงสาธารณสุขต่อประชากรสูงสุดกับต่ำสุดก็ยังต่างกัน 3.4 เท่า แพทย์เฉพาะทางก็กระจุกตัว สถานพยาบาลหนึ่งในสิบที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุดมีส่วนแบ่งแพทย์เฉพาะทางเพิ่มจากร้อยละ 61.6 เป็น 63.5 ระหว่างปี 2564–2567

8 ใน 10 ของพยาบาลวิชาชีพที่รับเข้าใหม่ไปแทนคนที่ออก จึงเพิ่มขึ้นจริงเพียงราว 2 ใน 10

เหตุการณ์รับเข้าและออก ต่อบุคลากรร้อยคนต่อปี

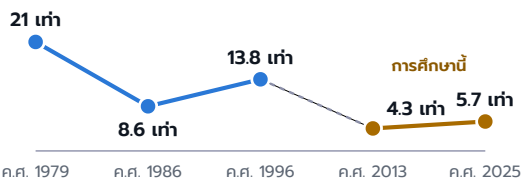


เหตุการณ์ต่อบุคลากรร้อยคนต่อปี ปีงบประมาณ 2560–2568 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทำไมช่องว่างจึงอาจกว้างขึ้นเอง?

จังหวัดที่มีคนทำงาน งบประมาณ และโอกาสมากอยู่แล้ว ยิ่งดึงดูดคนทำงานเพิ่มได้ง่าย หากไม่มีนโยบายช่วยพื้นที่ขาดแคลน ช่องว่างอาจยิ่งกว้าง ตัวอย่างเช่น ในปี 2556 กรุงเทพฯ มีแพทย์ทุกสังกัดต่อประชากรเป็น 4.3 เท่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5.7 เท่าในปี 2568

กรุงเทพฯ มีแพทย์ต่อประชากรเป็นกี่เท่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ค.ศ. 1979–1996: Wibulpolprasert และ Pengpaibon (2003) บันทึกเชิงพรรณนา · ค.ศ. 2013 และ 2025: การศึกษาครั้งนี้ แพทย์ทุกสังกัดต่อประชากรทะเบียนราษฎร ต่างแหล่งจากชุดเดิม เทียบได้เพียงขนาด

มีหมอใหม่แล้ว ต้องมีที่ให้ทำงาน และทำให้อยากอยู่ต่อ

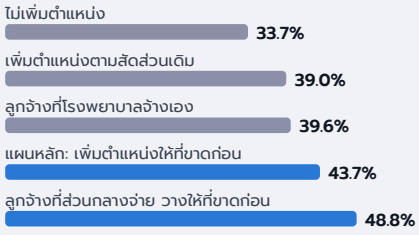
ข้อค้นพบที่ 4

เพิ่มตำแหน่งให้จังหวัดที่ขาดก่อน ได้ผลกว่าแบ่งตามเดิม

แพทย์ใหม่ที่ต้องการทำงานในระบบราชการต้องมีตำแหน่งว่างพร้อมงบจ้าง แบบจำลองพบว่า หากไม่เพิ่มตำแหน่งเลยจนถึงปี 2583 จะมีแพทย์ใหม่ 5,442 คนที่ไม่มีตำแหน่งรองรับ ต้องจ้างด้วยวิธีอื่นหรือออกจากระบบ สำหรับ 19 จังหวัดที่ขาดแพทย์มากที่สุด แบบจำลองเปรียบเทียบผลในปี 2583 โดยใช้เป้าหมายแพทย์ต่อประชากร 1:1,000 ได้ผลต่างกันตามกติกาจ้าง ดังกราฟ ทั้งหมดนี้เป็นผลจำลองภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่ใช่ผลที่จะเกิดขึ้นแน่นอน

2.0 เท่า ของตำแหน่งที่แผนหลักเพิ่ม หากเพิ่มตามสัดส่วนเดิมเพื่อให้จังหวัดที่ขาดได้ผลเท่ากัน

ร้อยละของเป้าแพทย์ที่ 19 จังหวัดต่ำสุดจะมีใน พ.ศ. 2583 ตามกติกาจ้าง



ร้อยละของเป้าตัวอย่างแพทย์ต่อประชากร 1:1,000 ที่กระทรวงรับผิดชอบ ซึ่งไม่ใช่มาตรฐานของกระทรวง กลุ่มล่างคือ 19 จังหวัดที่ห่างเป้ามากที่สุด

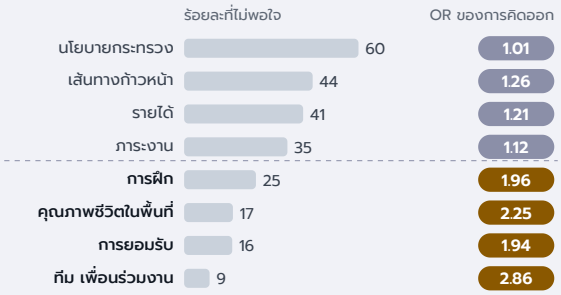
ข้อค้นพบที่ 5

ความไม่พอใจเรื่องใดมาพร้อมกับการคิดออก

การสำรวจบุคลากร 734 คนใน 66 จังหวัด (กรกฎาคม–ตุลาคม 2569) พบว่า ร้อยละ 16 คิดจะออกจากราชการหรือสังกัดภายในสามปี เรื่องที่ไม่พอใจกันมาก เช่น นโยบายกำลังคนและรายได้ ไม่ได้สัมพันธ์กับความคิดจะออกอย่างชัดเจน เมื่อเทียบคนในวิชาชีพและระดับหน่วยบริการเดียวกัน แต่ความไม่พอใจเรื่องทีมและเพื่อนร่วมงาน การใช้ชีวิตในพื้นที่ โอกาสฝึกอบรม และการได้รับการยอมรับมีความสัมพันธ์กับความคิดจะออก ตัวเลขนี้บอกความสัมพันธ์ ไม่ได้ยืนยันว่าอะไรเป็นสาเหตุ

2.86 เท่า OR ของการคิดออกในผู้ที่ไม่พอใจทีมและเพื่อนร่วมงาน เทียบผู้ที่พอใจ ส่วนเรื่องรายได้อยู่ที่ 1.21 เท่า

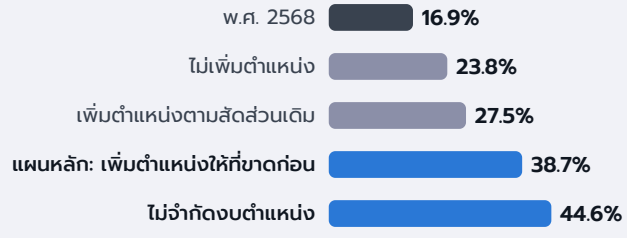
เรื่องที่คนไม่พอใจ กับความสัมพันธ์ต่อการคิดออกในสามปี



OR เทียบโอกาสคิดออกของผู้ไม่พอใจเรื่องนั้นกับผู้ที่พอใจ สีทองคือเรื่องที่สัมพันธ์กับการคิดออกอย่างชัดเจน

ดูตัวอย่าง “บึงกาฬ”

ปี 2568 บึงกาฬมีแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 72 คน ตำแหน่งที่มีงบจ้าง 137 ตำแหน่ง และแพทย์ออกจากระบบปีละร้อยละ 13.4 แบบจำลองปี 2583 พบว่ายังไม่ถึงเป้าหมายทุกแผน แต่ผลดีขึ้นต่างกัน



ร้อยละของเป้าตัวอย่างแพทย์ต่อประชากร 1:1,000 ที่กระทรวงรับผิดชอบ เป็นผลจากการทำแบบจำลองเท่านั้น

อย่าดูแค่ตัวเลข “ดีขึ้น”

1. เพิ่มคน เวลา และเครื่องมือให้บริการสุขภาพ
2. ลดเป้าหมาย เช่น ไม่นับประชาชนบางกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบ
3. งานยังอยู่ แต่ให้ครอบครัวหรือวิชาชีพอื่นรับภาระแทน

ทางแรกช่วยขยายบริการได้จริง แต่สองทางหลังทำให้ตัวชี้วัดดีขึ้นโดยที่ภาระไม่ได้หายไป

เจ็ดเรื่องที่ต้องทำพร้อมกัน

การแก้ปัญหาบุคลากรสุขภาพไม่ใช่แค่ผลิตคนเพิ่ม แต่ต้องทำให้ข้อมูล ตำแหน่ง งบจ้าง และชีวิตคนทำงานเดินไปด้วยกัน เพื่อให้ทุกพื้นที่มีคนทำงานดูแลผู้ป่วยเพียงพอ

1. **นับคนให้ตรงกัน**
   ตกลงให้ชัดว่านับวิชาชีพใด สังกัดใด และพื้นที่ใด เพื่อไม่ให้แต่ละหน่วยงานวางแผนจากตัวเลขคนละชุด
2. **เปรียบเทียบทุกแผนด้วยเกณฑ์เดียวกัน**
   เปิดให้ทุกฝ่ายเห็นว่าแต่ละทางเลือกช่วยพื้นที่ขาดได้แค่ไหน และช่องว่างระหว่างจังหวัดลดลงหรือไม่
3. **ทบทวนตำแหน่งทุกห้าปี ให้พื้นที่ขาดก่อน**
   จัดงบและตำแหน่งตามความจำเป็น แล้วใช้ตำแหน่งว่างจริงจัดสรรแพทย์ใหม่ทุกปี พร้อมเตรียมทีมและที่ทำงาน
4. **ฝึกแพทย์ให้ตรงกับงานที่จะมีรองรับ**
   วางแผนร่วมกันระหว่างสถาบันผลิตแพทย์และผู้จ้าง รวมถึงตำแหน่งสำหรับผู้กลับจากฝึกเฉพาะทาง
5. **ทำให้คนอยากอยู่ต่อ**
   เสริมทีมงาน โอกาสฝึกอบรม การยอมรับ และคุณภาพชีวิต โดยแก้รายได้ ความมั่นคงในการจ้าง และภาระงานควบคู่กัน
6. **นับงานที่ครอบครัวต้องรับด้วย**
   เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านเร็วขึ้น อย่าลืมนับงานจัดยา เฝ้าอาการ และดูแลที่ตกกับญาติหรือผู้ดูแล
7. **เปิดข้อมูลและรับฟังเสียงคนในพื้นที่**
   ทบทวนพื้นที่เป้าหมายทุกปี ประกาศเกณฑ์ล่วงหน้า และเปิดให้ประชาชนและผู้ทำงานตรวจสอบและทักท้วงด้วยหลักฐาน

สี่คำถามที่สังคมต้องร่วมตัดสิน

ตัวเลขบอกผลและทรัพยากรที่แต่ละทางเลือกต้องใช้ แต่ประชาชนและผู้รับผิดชอบต้องร่วมกันเลือก

1. ควรเพิ่มคนตามจำนวนผู้มารักษา หรือความเจ็บป่วยของประชาชน
2. ส่วนกลางหรือโรงพยาบาลควรเป็นผู้จ่ายค่าจ้าง หากต้องการบุคลากรมากกว่ากรอบที่ตั้งไว้ และพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมด้านใด
3. เมื่อคนไม่พอ ใครต้องรับงานเพิ่ม: บุคลากรหรือครอบครัว
4. ใครร่วมกำหนดได้ว่าคนและบริการสุขภาพเท่าใดจึงพอ และจะตกลงร่วมกันอย่างไร

แบบจำลองช่วยตัดสินใจได้ แต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

- ✓ ผ่านด้านจำนวนคน: เมื่อทดสอบกับข้อมูลย้อนหลัง แบบจำลองคาดจำนวนแพทย์รายจังหวัดล่วงหน้าสามปี คลาดเคลื่อนเฉลี่ย 28.1 คน ดีกว่าการสมมติว่าจำนวนแพทย์จะเท่าเดิม ซึ่งคลาด 33.3 คน
- ✗ ไม่ผ่านด้านช่วงคาดการณ์: ยังคาดช่วงความไม่แน่นอนได้ไม่ดี
- ✗ ไม่ผ่านด้านพื้นที่: ระบุรายชื่อ 19 จังหวัดที่ขาดแคลนได้ไม่แม่นถึงเกณฑ์ที่กำหนด

แบบจำลองจึงเหมาะใช้ “เปรียบเทียบทางเลือกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน” มากกว่ายึดรายชื่อจังหวัดเป้าหมายแบบตายตัว

ข้อควรรู้

- ตัวเลขรับเข้า–ออกนับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่จำนวนคนที่ไม่ซ้ำกัน
- เป้าหมาย 1:1,000 เป็นเพียงเกณฑ์ตัวอย่างของงานวิจัย ไม่ใช่มาตรฐานของกระทรวง
- ความคิดจะออกไม่ใช่การออกจริง

อ่านผล ทดลองแผน ดาวน์โหลดข้อมูล

สแกนรหัสหรือเปิดเว็บไซต์เพื่ออ่านวิธีศึกษา กราฟ และข้อมูล ในส่วนทดลองจัดสรรกำลังคน (Workforce Lab) คุณเปลี่ยนกติกาการเพิ่มตำแหน่งและดูผลต่อแต่ละพื้นที่ได้

psitthirat.github.io/HRH-model

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานผลการวิจัยโครงการการพัฒนาแนวทางและนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพโดยใช้แบบจำลองแบบบูรณาการ (ตุลาคม 2569).